

Principaux syndromes psychiatriques (adulte) – nosologie

Introduction : la médecine somatique fait la distinction entre « symptômes » (ce que le malade dit ressentir) et les « signes » (ce qui est objectivé lors de l'examen médical). En psychiatrie, cette distinction est beaucoup plus floue. On ne peut pas « observer » la vie psychique d'un individu comme on observe un objet. La sémiologie apparaît toujours dans le cadre d'une relation interpersonnelle. De plus, le soignant se base en partie sur ses propres réactions (« contre transfert ») pour construire le diagnostic.

Pour de nombreux traits de la vie psychique, la limite entre ce qui est normal et ce qui est pathologique n'est pas claire. Il est difficile de fixer un seuil quantitatif normal pour les émotions. Le caractère pathologique d'une manifestation pourra être déterminé par :

- le contexte relationnel et culturel dans lequel cette manifestation apparaît
- la souffrance que cette manifestation induit chez l'individu ou chez ses proches (voire dans la société).
- son apparition au sein d'un ensemble syndromique de manifestations.

Exemples de la tristesse – un large spectre : la dépression se situe à la fin du spectre de la tristesse. Mais il est difficile de dire à partir de quand.

- « Je suis très triste parce que mon grand-père est décédé hier soir. » Clairement lié à un événement tragique, il y a de fortes chances que la personne se remette avec le temps.
- « Depuis quatre mois que j'ai dû aller vivre à Glasgow pour mon travail, je me sens triste tous les soirs et je n'ai même pas envie de regarder la TV. » Lié à un mode de vie, plus durable et déjà plus inquiétant...
- « Depuis que j'ai perdu mon emploi, je me sens triste, j'ai l'impression de ne rien valoir, je n'ai pas l'énergie pour rechercher un travail, je mange peu, et je me réveille toutes les nuits vers 4 heures du matin. » Est-ce que ce patient est dépressif ? Difficile à trancher !

On verra souvent dans ces divers syndromes :

- Tendance à agir de manière impulsive
- Actes hétéo- et auto-agressifs (y compris suicidalité)
- Abus de substances, dépendances etc.

Troubles de l'humeur : dépression et troubles bipolaires (= syndromes maniaco-dépressifs)

Troubles psychotiques : se manifestent notamment dans les maladies présentant un trouble de rapport à la réalité (psychoses = perte de contact avec la réalité: schizophrénie). Mais ces troubles peuvent aussi être retrouvés dans les troubles de l'humeur et addictions.

Délires ou idées délirantes : le délire naît sur fond de modification générale du vécu et se manifeste par une appréciation erronée de la réalité. Cette conviction absolue mais erronée est irréductible par la logique/l'évidence des faits, et n'est pas expliquée par l'appartenance à un groupe culturel (le groupe ne partage pas ces croyances). Le délire peut être systématisé ou non : il est dit systématisé si la croyance paraît cohérente même si celle-ci ne s'établirait que dans l'esprit de peu de personnes. Par exemple, lors de délire paranoïaque (délire qui est systématisé), le patient explique être persécuté, il donne des raisons possibles de cette persécution, et parfois même l'interlocuteur adhère au discours. Le délire est dit non systématisé si la croyance paraît aux oreilles du clinicien ou de l'entourage comme incohérentes. À différencier selon le contenu :

- mystique : ex se croire envoyé de Dieu, investi de pouvoirs ou d'une mission particulière
- de persécution (ou paranoïde) : se croire victime ou agent de persécution
- de ruine : je suis responsable de mon malheur/du malheur des autres
- hypocondriaque
- de grandeur : se croire célèbre, puissant, intouchable (généralement domaine fantastique, souvent avec tendances surnaturelles ou religieuses)
- de référence : croyance que certains éléments dans l'environnement possèdent signification particulière. Ex télé/journaux qui s'adressent directement à nous (Gad), « signes » (Jeanne d'Arc)

Troubles de perception : peuvent être acoustico-verbales, auditives, visuelles, cénesthésique, olfactives, gustatives etc.

- Illusion : perception faussée du réel (l'objet réel - stimulus - est mal identifié)
- Hallucinations : perceptions par une voie sensorielle alors qu'il n'y a pas de stimulus

Troubles du moi : troubles de l'éprouvé de l'autre ou de l'environnement, du vécu d'unité du moi ou de l'apparence du moi

- Dépersonnalisation : sentiment d'être irréel, transformé
- Déréalisation : personnes et objets semblent irréels
- Devinement de la pensée : les pensées n'appartiennent plus au patient lui-même, d'autres y participent et savent ce qu'il pense
- Vol de la pensée : les pensées sont enlevées ou prélevées
- Pensées imposées : les pensées sont vécues comme influencées, fabriquées, dirigées ou gouvernées

Troubles formels de la pensée : se manifestent dans le langage (peuvent aussi s'observer chez les bipolaires)

- Pensée ralentie
- Pensée circonscrite : ne distingue pas l'essentiel de l'accessoire. Ne peuvent pas raconter histoire sans s'attarder sur détails inutiles et perdre le fil.
- Fuite des idées : afflux d'idées qui ne sont pas dirigées par un projet. Le but de la pensée est en changement permanent
- Réponses à côté : réponses incongrues même à des questions simples
- Néologismes : création de nouveaux mots
- Pensée incohérente

Troubles schizo-affectifs : combine les troubles de l'humeur et la schizophrénie

Troubles anxieux : englobe trouble obsessionnel compulsif et anxiété généralisée. Préoccupations non délirantes qui déterminent parfois le comportement.

- Méfiance non-délirante : attitude soupçonneuse, tantôt anxieuse/hostile (entourage perçu comme malveillant)
- Phobies : peur de certaines situations ou objets qui mènent à des conduites d'évitement
- Obsessions : idées et représentations qui s'imposent de manière répétée et sont vécues comme absurdes
- Compulsions : conduites que le sujet accomplit toujours sous la force de contraintes intérieures obsédantes. Patients sont conscients de l'absurdité mais le font pour soulager leur mal-être.

Troubles relationnels : troubles de la personnalité

Addictions : alcoolisme, toxicomanie, jeux pathologiques

Remarques : les symptômes ne sont pas propres à un seul diagnostic (tout comme la fièvre s'observe dans les pathologies infectieuses et tumorales par exemple). La dépression par exemple se voit dans les troubles dépressifs, mais aussi dans les troubles bipolaires ou dans la schizophrénie. Les symptômes psychotiques se voient caricaturalement dans la schizophrénie mais s'observent aussi dans les troubles dépressifs, bipolaires ou organiques. Le fait d'entendre des voix ne veut pas forcément dire qu'on est schizophrène !